

TD VIH-SIDA par chapitre — L2

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTÉ

Licence 2 Sage-femme / Maïeuticien — Unité Pédagogique de Médecine, Cellule VIH

VIH - SIDA

Travaux Dirigés — Banque de questions par chapitre

15 QCD et 10 QCM par chapitre — sans corrigé

13 chapitres : traitement ARV, molécules, interactions, modalités thérapeutiques, prévention, suivi, soins et soutien, et les six volets OEV

(éducation, économique, protection, psychosocial, abri et soins, prévention jeunes)

Document réalisé à partir du cours officiel « Cours de VIH SIDA » — INFAS

Sommaire

1. Introduction et directives du traitement ARV3

2. Présentation des molécules antirétrovirales6

3. Interactions alimentaires et médicamenteuses9

4. Modalités thérapeutiques12

5. Prévention (prophylaxie)15

6. Suivi du traitement ARV18

7. Soins et soutien21

8. OEV : Soutien à l'éducation et à la mise en apprentissage24

9. OEV : Soutien pour le renforcement économique27

10. OEV : Soutien à la protection30

11. OEV : Soutien psychosocial33

12. OEV : Soutien pour l'abri et les soins36

13. OEV : Interventions de prévention pour enfants, adolescents et jeunes adultes vulnérables au VIH39

Chapitre 1 — Introduction et directives du traitement ARV

I. QCD — Questions à choix direct

Cocher A pour vrai et B pour faux.

Le HAART est un traitement antirétroviral utilisant une association d'au moins trois molécules.

HAART signifie « Highly Active AntiRetroviral Therapy ».

Le TARV nécessite l'association de molécules appartenant à une seule et même classe thérapeutique.

Le traitement antirétroviral permet de réduire fortement et durablement la charge virale.

Le TARV a pour objectif d'éradiquer définitivement le VIH de l'organisme.

L'amélioration de l'espérance de vie fait partie des intérêts du TARV.

Le traitement antirétroviral doit être adapté au type de VIH (VIH-1, VIH-2 ou VIH 1+2).

Les 5 principes fondamentaux de la relation soignant-patient sont résumés par le sigle « 5A ».

Le patient peut arrêter son traitement dès que sa charge virale devient indétectable.

Le patient doit revenir chercher ses médicaments seulement après épuisement total de son stock.

Le suivi clinique du TARV comprend la surveillance du poids et de la tension artérielle.

L'indice de Karnofsky fait partie des éléments de surveillance clinique du TARV.

Le suivi paraclinique du TARV comprend une surveillance hématologique, immunologique, biochimique et virologique.

Une mauvaise observance thérapeutique favorise l'émergence de résistances virales.

La prise en charge du VIH ne nécessite pas de travail en équipe multidisciplinaire.

II. QCM — Questions à choix multiples

Veuillez cocher la ou les réponse(s) juste(s).

Cocher la bonne réponse. Le sigle HAART signifie :

- A. Human AntiRetroviral Active Therapy
- B. Highly Active AntiRetroviral Therapy
- C. Hautement Actif Anti-Rétroviral Traitement
- D. High Adherence AntiRetroviral Treatment

Cocher la bonne réponse. Un traitement antirétroviral efficace associe au minimum :

- A. Deux molécules d'une même classe
- B. Trois molécules appartenant à au moins deux classes thérapeutiques différentes
- C. Une seule molécule à forte dose
- D. Quatre classes thérapeutiques différentes obligatoirement

Cocher la bonne réponse. Parmi les intérêts suivants, lequel ne fait PAS partie des bénéfices attendus du HAART ?

- A. La réduction de la charge virale
- B. L'éradication complète et définitive du virus
- C. L'amélioration de la qualité de vie
- D. La réduction du nombre de nouvelles contaminations

Cocher la bonne réponse. Les 5 principes fondamentaux du counseling résumés par le sigle « 5A » incluent :

- A. Apprécier, Aviser, s'Accorder, Assister, Arranger
- B. Accueillir, Analyser, Administrer, Ajuster, Archiver
- C. Adhérer, Adapter, Alerter, Assurer, Améliorer
- D. Aucune de ces réponses

Cocher la bonne réponse. Le traitement antirétroviral doit être adapté :

- A. Uniquement au poids du patient
- B. Uniquement à l'âge du patient
- C. Au type de VIH et au mode de vie du patient
- D. Uniquement à la disponibilité des molécules

Cocher la bonne réponse. Concernant le renouvellement de son traitement, le patient doit revenir :

- A. Le jour même où son stock est épuisé
- B. Une semaine avant l'épuisement de son stock
- C. Un mois après l'épuisement de son stock
- D. Uniquement en cas de symptômes

Cocher la bonne réponse. Parmi les éléments suivants, lequel appartient à la surveillance clinique (et non paraclinique) du TARV ?

- A. Le bilan hématologique
- B. Le bilan virologique

- C. La tension artérielle
- D. Le bilan immunologique

Cocher la bonne réponse. Le suivi paraclinique du patient sous TARV comprend notamment une surveillance :

- A. Hématologique, immunologique, biochimique et virologique
- B. Uniquement radiologique
- C. Uniquement psychologique
- D. Uniquement sociale

Cocher la bonne réponse. Une mauvaise association des ARV associée à une mauvaise observance entraîne principalement :

- A. Une amélioration paradoxale de l'état du patient
- B. Un échec thérapeutique et l'émergence de résistances
- C. Une élimination plus rapide du virus
- D. Aucune conséquence si le traitement est repris plus tard

Cocher la bonne réponse. La prise en charge du patient sous TARV repose sur un travail :

- A. Strictement individuel du médecin prescripteur
- B. Multidisciplinaire, en équipe
- C. Réservé exclusivement aux pharmaciens
- D. Uniquement administratif

Chapitre 2 — Présentation des molécules antirétrovirales

I. QCD — Questions à choix direct

Cocher A pour vrai et B pour faux.

Les ARV bloquent le cycle de réplication du VIH mais ne détruisent pas directement le virus.

Les ARV sont qualifiés de « virucides » car ils détruisent le virus.

Le système nerveux central constitue un sanctuaire viral inaccessible aux ARV.

Les antirétroviraux se répartissent en quatre classes thérapeutiques différentes.

Les inhibiteurs de fusion et d'entrée bloquent la réplication virale en agissant sur l'enzyme protéase.

Les inhibiteurs de la transcriptase inverse comprennent les INTI et les INNTI.

Le VIH-2 est sensible à toutes les classes thérapeutiques d'ARV, au même titre que le VIH-1.

La Zidovudine (AZT) appartient à la classe des inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse.

Le Ténofovir (TDF), bien que classé parmi les INTI, est en réalité un analogue nucléotidique.

L'Abacavir peut provoquer une réaction d'hypersensibilité potentiellement grave, notamment chez les sujets africains.

La Névirapine peut être utilisée indifféremment chez les patients infectés par le VIH-1 ou le VIH-2.

Le Ritonavir est aujourd'hui principalement utilisé comme « booster » d'un autre inhibiteur de protéase plutôt que seul.

Le syndrome de reconstitution immunitaire survient généralement plusieurs années après le début du traitement ARV.

Devant un syndrome de reconstitution immunitaire, il faut systématiquement arrêter le traitement ARV en cours.

Selon la classification OMS, un effet secondaire de grade 4 est un effet gravissime engageant le pronostic vital.

II. QCM — Questions à choix multiples

Veuillez cocher la ou les réponse(s) juste(s).

Cocher la bonne réponse. Les antirétroviraux agissent en :

- A. Détruisant directement les particules virales
- B. Bloquant le cycle de réplication du virus
- C. Renforçant uniquement le système immunitaire
- D. Empêchant la transmission mère-enfant uniquement

Cocher la bonne réponse. Le réservoir viral inaccessible aux ARV, du fait de la barrière hémato-encéphalique, est constitué par :

- A. Le foie
- B. La moelle osseuse
- C. Le système nerveux central
- D. Les ganglions lymphatiques

Cocher la bonne réponse. Les quatre classes thérapeutiques d'ARV sont :

- A. INTI, INNTI, inhibiteurs de l'intégrase, inhibiteurs de protéase
- B. Inhibiteurs de fusion/entrée, INTI/INNTI, inhibiteurs de l'intégrase, inhibiteurs de protéase
- C. Antibiotiques, antiviraux, antifongiques, antiparasitaires
- D. INTI, IP, vaccins, immunoglobulines

Cocher la bonne réponse. Les inhibiteurs de protéase empêchent :

- A. L'entrée du virus dans la cellule
- B. La formation de l'ADN proviral
- C. L'assemblage de nouvelles particules virales infectieuses
- D. L'intégration de l'ADN viral dans le génome cellulaire

Cocher la bonne réponse. Concernant la sensibilité aux ARV, le VIH-2 :

- A. Est sensible à toutes les classes, comme le VIH-1
- B. N'est pas sensible aux INNTI et à un inhibiteur de protéase (ATV)
- C. N'est sensible à aucune classe d'ARV
- D. N'est sensible qu'aux inhibiteurs de fusion

Cocher la bonne réponse. Parmi les molécules suivantes, laquelle appartient à la classe des INTI ?

- A. Névirapine
- B. Dolutégravir
- C. Zidovudine
- D. Ritonavir

Cocher la bonne réponse. La Névirapine est indiquée :

- A. Chez le VIH-1 uniquement
- B. Chez le VIH-2 uniquement
- C. Indifféremment chez le VIH-1 et le VIH-2
- D. Uniquement en association avec un inhibiteur de fusion

Cocher la bonne réponse. L'effet indésirable de classe le plus caractéristique du Ténofovir est :

- A. La toxicité hématologique
- B. La néphrotoxicité
- C. Les troubles neuropsychiatriques
- D. La lipodystrophie exclusive

Cocher la bonne réponse. Le syndrome de reconstitution immunitaire se caractérise par :

- A. Une augmentation des CD4, une baisse de la charge virale et l'aggravation d'une infection opportuniste
- B. Une baisse des CD4 et une augmentation de la charge virale
- C. Une disparition immédiate de toute infection opportuniste
- D. Un phénomène qui survient uniquement après un an de traitement

Cocher la bonne réponse. Selon la classification OMS de la toxicité des ARV, un effet secondaire de grade 3 impose généralement :

- A. Une simple surveillance médicale sans autre mesure
- B. L'arrêt du traitement
- C. La poursuite du traitement sans aucune surveillance
- D. Une hospitalisation systématique en soins intensifs uniquement

Chapitre 3 — Interactions alimentaires et médicamenteuses

I. QCD — Questions à choix direct

Cocher A pour vrai et B pour faux.

Les interactions alimentaires et médicamenteuses peuvent diminuer l'efficacité des ARV ou augmenter leur toxicité.

Tous les antirétroviraux ont une meilleure biodisponibilité lorsqu'ils sont pris à jeun.

Le Ritonavir à faible dose est utilisé pour « booster » les concentrations d'autres inhibiteurs de protéase.

Le Nelfinavir est très sensible à l'effet booster du Ritonavir.

La Rifampicine est un inducteur enzymatique puissant.

La Rifampicine est contre-indiquée avec tous les inhibiteurs de protéase non associés au Ritonavir.

L'association Rifampicine-Efavirenz est possible.

En cas de traitement antituberculeux par Rifampicine associé au LPV/r, il faut réduire la dose de Ritonavir.

Les inhibiteurs de protéase et certains INNTI peuvent réduire l'efficacité des contraceptifs oraux.

Le Dolutégravir augmente les concentrations de la metformine, imposant une surveillance de la glycémie.

Les anti-acides topiques peuvent être pris en même temps que n'importe quel ARV sans délai.

L'association de l'Artémisinine avec le Dolutégravir se fait sans effet notable.

L'association Quinine-Ritonavir entraîne une diminution des concentrations de quinine.

Les concentrations de codéine augmentent lorsqu'elle est associée au Ritonavir.

Il existe actuellement de nombreuses données validées sur les interactions entre ARV et médicaments traditionnelles dans notre contexte.

II. QCM — Questions à choix multiples

Veuillez cocher la ou les réponse(s) juste(s).

Cocher la bonne réponse. Une interaction médicamenteuse défavorable avec les ARV peut entraîner :

- A. Une diminution de l'efficacité des ARV uniquement
- B. Une augmentation de la toxicité uniquement
- C. Une diminution de l'efficacité ou une augmentation de la toxicité selon les cas
- D. Aucune conséquence clinique significative

Cocher la bonne réponse. Le terme « booster » un inhibiteur de protéase signifie :

- A. Diminuer sa concentration plasmatique
- B. Augmenter sa concentration plasmatique grâce au Ritonavir à faible dose
- C. Le remplacer par un autre IP
- D. L'associer à un antituberculeux

Cocher la bonne réponse. Parmi les inhibiteurs de protéase, celui qui est peu sensible à l'effet booster du Ritonavir est :

- A. Le Lopinavir
- B. Le Nelfinavir
- C. L'Atazanavir
- D. Le Darunavir

Cocher la bonne réponse. La Rifampicine est contre-indiquée avec :

- A. Tous les inhibiteurs de protéase non boostés par le Ritonavir
- B. L'Efavirenz uniquement
- C. La trithérapie INTI (ABC/AZT/3TC)
- D. Le Dolutégravir uniquement

Cocher la bonne réponse. En cas d'association Rifampicine-LPV/r, la conduite recommandée est de :

- A. Arrêter définitivement le LPV/r
- B. Rebooster le LPV/r avec 100 mg supplémentaires de Ritonavir
- C. Diminuer la dose de LPV/r de moitié
- D. Remplacer la Rifampicine par un autre antituberculeux sans exception

Cocher la bonne réponse. Lors de l'association Rifampicine et TDF+3TC+DTG (TLD), il est recommandé :

- A. De ne rien changer au schéma thérapeutique
- B. De prendre une dose supplémentaire de 50 mg de Dolutégravir 12 heures après le TLD
- C. D'arrêter le TLD pendant toute la durée du traitement antituberculeux
- D. De doubler la dose de Rifampicine

Cocher la bonne réponse. Certains inhibiteurs de protéase et INNTI peuvent interagir avec les contraceptifs oraux en :

- A. Réduisant l'efficacité contraceptive, imposant une double méthode de contraception
- B. Renforçant systématiquement l'efficacité contraceptive
- C. N'ayant aucune interaction connue
- D. Rendant la contraception orale obligatoire

Cocher la bonne réponse. Concernant l'association Artémisinine et INNTI, il est recommandé de :

- A. L'associer sans précaution particulière
- B. Déconseiller cette association en raison d'une diminution des concentrations de l'antipaludéen
- C. Augmenter systématiquement la dose d'INNTI
- D. L'associer uniquement chez l'enfant

Cocher la bonne réponse. Concernant l'association Quinine et INNTI, il faut :

- A. Diminuer la dose de quinine
- B. Augmenter la dose de quinine du fait d'une diminution de ses concentrations
- C. Arrêter la quinine définitivement
- D. Ne prendre aucune précaution

Cocher la bonne réponse. Pour rechercher les interactions médicamenteuses entre ARV et autres traitements, le site internet recommandé est celui de :

- A. L'Organisation Mondiale de la Santé
- B. L'université de Liverpool (hiv-druginteractions.org)
- C. Le CDC américain
- D. Le Ministère de la Santé de Côte d'Ivoire

Chapitre 4 — Modalités thérapeutiques

I. QCD — Questions à choix direct

Cocher A pour vrai et B pour faux.

Selon l'approche « Tester et Traiter Tous », tout patient dépisté positif au VIH est éligible au TARV quel que soit son taux de CD4.

L'éligibilité au TARV dans l'approche « Tester et Traiter Tous » dépend du stade clinique du patient.

Une prophylaxie primaire au cotrimoxazole doit être instituée en complément du TARV.

Le schéma de première ligne préférentiel chez l'adulte infecté par le VIH-1 est TDF+3TC+DTG (TLD).

Chez le VIH-2 ou en cas de double infection (VIH1+VIH2), le schéma alternatif recommandé est TDF+3TC+EFV.

Le Ténofovir doit être évité en cas d'insuffisance rénale.

L'Efavirenz peut être utilisé sans restriction chez tout patient présentant des troubles neuropsychiatriques graves.

En cas de co-infection TB/VIH, une dose supplémentaire de Dolutégravir est recommandée 12 heures après la prise du TLD.

En cas de trouble de la fonction rénale, il est recommandé de remplacer le TDF par l'ABC.

Chez l'enfant de moins de 10 ans pesant moins de 20 kg, la dose de Dolutégravir recommandée est de 50 mg.

La prescription du TLD chez l'enfant/adolescent nécessite un poids d'au moins 35 kg et un âge d'au moins 12 ans.

Chez l'adolescente réglée, la prescription du Dolutégravir doit s'accompagner d'informations sur la contraception.

Chez la femme enceinte infectée par le VIH-1, reçue au premier trimestre, le schéma recommandé est TDF+3TC+EFV.

Chez la femme enceinte reçue à partir du deuxième trimestre, quel que soit le type de VIH, le schéma recommandé est TDF+3TC+DTG (TLD).

Une femme déjà sous TARV efficace qui débute une grossesse doit obligatoirement changer de schéma thérapeutique.

II. QCM — Questions à choix multiples

Veuillez cocher la ou les réponse(s) juste(s).

Cocher la bonne réponse. Selon l'approche « Tester et Traiter Tous », un patient dépisté positif au VIH est éligible au TARV :

- A. Uniquement si son taux de CD4 est bas
- B. Uniquement au stade clinique avancé
- C. Quel que soit son taux de CD4 et son stade clinique
- D. Uniquement en cas de grossesse

Cocher la bonne réponse. Le schéma thérapeutique préférentiel de première ligne chez l'adulte infecté par le VIH-1 est :

- A. AZT+3TC+NVP

B. TDF+3TC+DTG (TLD)

C. ABC+3TC+LPV/r

D. TDF+3TC+EFV exclusivement

Cocher la bonne réponse. Chez l'adulte infecté par le VIH-2 ou en dual (VIH1+VIH2), le schéma recommandé est :

A. TDF+3TC+DTG

B. TDF+3TC+LPV/r

C. ABC+3TC+AZT

D. TDF+3TC+EFV

Cocher la bonne réponse. Le Ténofovir doit être évité notamment en cas de :

A. Diabète bien contrôlé

B. Insuffisance rénale

C. Grossesse au premier trimestre

D. Co-infection tuberculeuse

Cocher la bonne réponse. En cas de co-infection TB/VIH sous TLD, la conduite recommandée est :

A. D'arrêter le TLD pendant le traitement antituberculeux

B. D'ajouter une dose supplémentaire de 50 mg de Dolutégravir 12 heures après le TLD

C. De remplacer le TLD par un schéma à base d'Efavirenz systématiquement

D. De doubler la dose de TDF

Cocher la bonne réponse. En cas de trouble de la fonction rénale chez un patient sous TDF, il faut :

A. Remplacer le TDF par l'ABC

B. Augmenter la dose de TDF

C. Associer le TDF à la Rifampicine

D. Arrêter tout traitement ARV

Cocher la bonne réponse. Chez l'enfant de moins de 10 ans pesant 35 kg ou plus, le schéma préférentiel est :

A. ABC+3TC+DTG

B. TDF+3TC+DTG (TLD)

C. AZT+3TC+NVP

D. ABC+3TC+LPV/r exclusivement

Cocher la bonne réponse. La dose de Dolutégravir recommandée chez l'enfant pesant moins de 20 kg est de :

A. 10 mg

B. 25 mg

C. 50 mg

D. 100 mg

Cocher la bonne réponse. Chez la femme enceinte infectée par le VIH-1 et reçue au premier trimestre de grossesse, le schéma recommandé est :

A. TDF+3TC+DTG

B. TDF+3TC+EFV

C. TDF+3TC+LPV/r

D. ABC+3TC+AZT

Cocher la bonne réponse. Une femme sous TARV efficace qui débute une grossesse doit :

- A. Arrêter immédiatement son traitement jusqu'à l'accouchement
- B. Poursuivre son traitement en cours s'il est toujours efficace
- C. Changer systématiquement pour un schéma à base d'Efavirenz
- D. Être mise sous monothérapie par précaution

Chapitre 5 — Prévention (prophylaxie)

I. QCD — Questions à choix direct

Cocher A pour vrai et B pour faux.

La femme enceinte séropositive au VIH reçoit un traitement antirétroviral à vie, selon l'option B+.

Le traitement prophylactique du nouveau-né exposé est identique quel que soit le niveau de risque de transmission.

Un enfant est classé à faible risque de transmission si sa mère a une charge virale inférieure à 1000 copies/ml au troisième trimestre.

Un enfant est classé à haut risque si sa mère a été mise sous TARV moins de 4 semaines avant l'accouchement.

Le choix d'allaiter son enfant classe automatiquement la mère et l'enfant en faible risque de transmission.

Il suffit qu'un seul critère de haut risque soit présent pour classer l'enfant à haut risque.

La PrEP et la PEP consistent en l'utilisation d'ARV chez des personnes séronégatives pour prévenir l'acquisition du VIH.

La PrEP s'adresse uniquement aux personnes déjà infectées par le VIH.

L'âge minimum requis pour être éligible à la PrEP est de 16 ans.

Une clairance de la créatinine supérieure à 60 ml/min est un critère d'éligibilité à la PrEP.

La molécule utilisée pour la PrEP est l'association Ténofovir Disoproxil et Lamivudine.

La PrEP continue est la seule option recommandée chez les femmes et les personnes infectées par l'hépatite B.

La PrEP à la demande consiste en la prise d'un comprimé unique, une seule fois, avant le rapport à risque.

Un accident d'exposition au sang (AES) se définit uniquement par une piqûre avec une aiguille contaminée.

La prophylaxie post-exposition (PEP) doit être initiée dans les 72 heures suivant l'exposition, pour une durée de 28 jours.

II. QCM — Questions à choix multiples

Veillez cocher la ou les réponse(s) juste(s).

Cocher la bonne réponse. La femme enceinte séropositive au VIH reçoit un traitement antirétroviral :

- A. Uniquement pendant la grossesse
- B. À vie, selon l'option B+
- C. Uniquement au moment de l'accouchement
- D. Uniquement si son taux de CD4 est bas

Cocher la bonne réponse. Un enfant exposé est classé à haut risque de transmission du VIH si sa mère, entre autres :

- A. A une charge virale inférieure à 1000 copies/ml au 3ème trimestre
- B. A été mise sous TARV au moins 4 semaines avant l'accouchement
- C. A été diagnostiquée séropositive en salle d'accouchement
- D. N'a pas choisi d'allaiter son enfant

Cocher la bonne réponse. Concernant la classification du risque de transmission chez le nouveau-né exposé :

- A. Il faut réunir tous les critères de haut risque pour classer l'enfant à haut risque
- B. Un seul critère de haut risque suffit pour classer l'enfant à haut risque
- C. Le mode d'accouchement n'a aucune influence sur cette classification
- D. Seul le taux de CD4 maternel est pris en compte

Cocher la bonne réponse. La PrEP et la PEP ont pour but commun :

- A. De traiter une infection à VIH déjà installée
- B. D'utiliser des ARV chez des personnes séronégatives pour prévenir l'acquisition du VIH
- C. De remplacer la vaccination contre l'hépatite B
- D. De traiter les infections opportunistes

Cocher la bonne réponse. Parmi les critères d'éligibilité à la PrEP figurent :

- A. Un âge d'au moins 16 ans et une sérologie VIH négative
- B. Une sérologie VIH positive récente
- C. Une clairance de la créatinine inférieure à 60 ml/min
- D. Un âge maximal de 25 ans

Cocher la bonne réponse. La molécule utilisée pour la PrEP est :

- A. Efavirenz seul
- B. Dolutégravir seul
- C. Ténofovir Disoproxil associé à la Lamivudine (TDF/3TC)
- D. Névirapine associée à la Zidovudine

Cocher la bonne réponse. La PrEP continue consiste en la prise de :

- A. Un comprimé par jour durant toute la durée de l'exposition
- B. Deux comprimés une seule fois par semaine
- C. Un comprimé uniquement après chaque rapport à risque
- D. Trois comprimés par jour en continu

Cocher la bonne réponse. Dans la PrEP à la demande, après la double dose initiale, les comprimés suivants doivent être pris :

- A. À 24 heures d'intervalle, à raison d'un comprimé après la première puis un après la deuxième prise
- B. Immédiatement tous ensemble
- C. Une semaine plus tard
- D. Il n'y a pas d'autre prise nécessaire

Cocher la bonne réponse. Un accident d'exposition au sang (AES) se définit comme un contact accidentel avec du sang ou un produit biologique par :

- A. Voie percutanée, projection sur muqueuse ou peau lésée
- B. Voie orale exclusivement
- C. Voie respiratoire exclusivement
- D. Contact avec une peau saine et intacte uniquement

Cocher la bonne réponse. Chez une personne de plus de 10 ans (ou plus de 35 kg) victime d'un AES avec sérologie VIH négative, la prophylaxie post-exposition recommandée est :

- A. TDF+3TC+DTG (TLD) dans les 72h suivant l'exposition, pendant 28 jours
- B. ABC+3TC+DTG pendant 6 mois
- C. Zidovudine seule pendant 7 jours

D. Aucun traitement n'est nécessaire avant confirmation de la séroconversion

Chapitre 6 — Suivi du traitement ARV

I. QCD — Questions à choix direct

Cocher A pour vrai et B pour faux.

L'observance thérapeutique comprend deux notions : l'adhésion et la compliance.

Le seuil de bonne observance pour le TARV se situe au-dessus de 90 %.

Une mauvaise observance se définit par l'oubli d'une dose sur une période de 6 mois.

Il est recommandé d'utiliser au moins deux outils pour évaluer l'observance.

L'observation directe thérapeutique (DOT) est un outil d'évaluation de l'observance.

Une bonne observance thérapeutique augmente le risque de développement de résistances virales.

Depuis 2015, la charge virale est l'outil préférentiel de suivi du traitement ARV en Côte d'Ivoire.

Un patient ayant une charge virale indétectable inférieure à 200 copies/ml doit changer immédiatement de ligne thérapeutique.

Une charge virale non supprimée supérieure à 1000 copies/ml impose la conduite de séances d'éducation thérapeutique avant de refaire le contrôle.

L'échec thérapeutique se définit notamment par une charge virale supérieure à 1000 copies/ml persistant après renforcement de l'observance.

Le patient est dit « perdu de vue » lorsqu'il a manqué son rendez-vous depuis 90 jours, norme inchangée depuis les débuts du programme.

Le patient « perdu de vue » est systématiquement retiré de la file active.

La file active comprend uniquement les patients nouvellement mis sous traitement ARV.

En cas d'arrêt du TARV avec un schéma à deux INTI plus un IP, il est recommandé d'arrêter tous les médicaments en même temps.

Un patient présentant une anémie sévère ou une insuffisance rénale sévère doit être référé vers une structure spécialisée.

II. QCM — Questions à choix multiples

Veuillez cocher la ou les réponse(s) juste(s).

Cocher la bonne réponse. L'observance thérapeutique se définit comme :

A. La capacité du patient à prendre son traitement selon la prescription donnée

B. La disponibilité des ARV dans les pharmacies

C. Le nombre de comprimés restants en fin de mois

D. La durée totale du traitement antirétroviral

Cocher la bonne réponse. Le seuil de bonne observance pour une réponse optimale au TARV se situe :

A. Au-dessus de 50 %

B. Au-dessus de 70 %

C. Au-dessus de 90 %, voire 95 %

D. Exactement à 100 % sans aucune tolérance

Cocher la bonne réponse. La mauvaise observance se définit comme le fait de manquer :

A. Plus d'une dose sur une période de 10 jours

B. Une seule dose par an

C. Plus de dix doses par semaine

D. Une dose tous les 6 mois

Cocher la bonne réponse. Parmi les outils d'évaluation de l'observance figurent :

- A. L'auto-questionnaire et l'observation directe thérapeutique (DOT)
- B. Uniquement la charge virale
- C. Uniquement l'examen clinique
- D. Uniquement le poids du patient

Cocher la bonne réponse. Devant une charge virale supprimée mais comprise entre 200 et 1000 copies/ml, la conduite à tenir est :

- A. De changer immédiatement de ligne thérapeutique
- B. De renforcer le conseil à l'observance tout en poursuivant le traitement en cours
- C. D'arrêter tout traitement ARV
- D. De considérer d'emblée un échec thérapeutique

Cocher la bonne réponse. Devant une charge virale non supprimée supérieure à 1000 copies/ml, il faut :

- A. Conduire des séances d'éducation thérapeutique puis refaire la charge virale
- B. Changer immédiatement de ligne sans autre évaluation
- C. Ne rien faire jusqu'au prochain bilan annuel
- D. Arrêter le TARV pendant 3 mois

Cocher la bonne réponse. L'échec thérapeutique est défini par une charge virale supérieure à 1000 copies/ml après :

- A. 6 mois de traitement continu bien conduit, confirmée au contrôle après renforcement de l'observance
- B. 1 semaine de traitement
- C. 1 mois de traitement, sans confirmation nécessaire
- D. Une seule mesure isolée, quel que soit le délai

Cocher la bonne réponse. Selon la définition actualisée, un patient est dit « perdu de vue » lorsqu'il a manqué son rendez-vous depuis :

- A. 7 jours
- B. 28 jours
- C. 90 jours
- D. 6 mois

Cocher la bonne réponse. La file active correspond à :

- A. L'ensemble des patients VIH+ sous ARV ayant de quoi couvrir leurs besoins de traitement, déduction faite des attritions
- B. Uniquement les nouveaux patients mis sous traitement
- C. Uniquement les patients transférés d'une autre structure
- D. L'ensemble des patients décédés au cours de l'année

Cocher la bonne réponse. Parmi les situations suivantes, laquelle impose de référer un patient vers une structure spécialisée ?

- A. Une bonne observance thérapeutique
- B. Une charge virale indétectable
- C. Une co-infection TB/VIH
- D. Une simple consultation de routine sans complication

I. QCD — Questions à choix direct

Cocher A pour vrai et B pour faux.

Les soins et soutien sont la traduction française du terme anglais « supportive care ».

Les soins et soutien ne concernent que la période suivant le décès du patient.

Le but des soins et soutien est l'amélioration de la dignité, de la qualité et de la durée de vie des PVVIH.

Le dispositif national de soins et soutien comprend huit composantes.

Les huit composantes des soins et soutien ont été validées en octobre 2020.

Le soutien médical est l'une des huit composantes des soins et soutien.

Le soutien à l'éducation et à la mise en apprentissage ne fait pas partie des huit composantes officielles.

La thérapie préventive de la tuberculose fait partie des tâches du soutien médical.

L'éducation thérapeutique du patient (ETP) relève du soutien médical.

La prévention du cancer du col de l'utérus fait partie des tâches attribuées au soutien médical.

Le soutien psychologique inclut la prévention et la prise en charge du burnout chez le soignant.

Le soutien spirituel exclut toute implication des leaders religieux dans la prise en charge des PVVIH.

La lutte contre la stigmatisation et la discrimination relève du soutien juridique.

La mise en place des AGR (activités génératrices de revenus) relève du soutien économique.

Les soins et soutien contribuent à la réduction des nouvelles infections par la rétention durable des PVVIH dans les soins.

II. QCM — Questions à choix multiples

Veuillez cocher la ou les réponse(s) juste(s).

Cocher la bonne réponse. Le terme « soins et soutien » est la traduction de l'expression anglaise :

A. Supportive care

B. Primary care

C. Palliative care only

D. Home care

Cocher la bonne réponse. Les soins et soutien sont nécessaires :

A. Uniquement après le décès du patient

B. Uniquement au moment du diagnostic

C. Dès le diagnostic, pendant la maladie et après le décès (deuil familial)

D. Uniquement pendant l'hospitalisation

Cocher la bonne réponse. Le dispositif national de soins et soutien comprend :

A. 4 composantes

B. 6 composantes

C. 8 composantes

D. 10 composantes

Cocher la bonne réponse. Ce dispositif national de soins et soutien a été validé en :

A. 2015

B. 2018

C. Octobre 2020

D. 2023

Cocher la bonne réponse. Parmi les composantes suivantes, laquelle ne fait PAS partie des huit composantes officielles des soins et soutien ?

- A. Le soutien économique
- B. Le soutien juridique
- C. Le soutien médical
- D. Le soutien militaire

Cocher la bonne réponse. La distribution communautaire des ARV relève de la composante :

- A. Soutien médical
- B. Soutien social
- C. Soutien juridique
- D. Soutien économique

Cocher la bonne réponse. La mise en place de groupes de parole / soutien relève de la composante :

- A. Soutien spirituel
- B. Soutien psychologique
- C. Soutien juridique
- D. Soutien nutritionnel

Cocher la bonne réponse. La mise en place des AVEC/AUEC/GEC (groupes d'épargne communautaires) relève de la composante :

- A. Soutien économique
- B. Soutien social
- C. Soutien spirituel
- D. Soutien médical

Cocher la bonne réponse. La lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) relève de la composante :

- A. Soutien nutritionnel
- B. Soutien juridique
- C. Soutien médical
- D. Soutien psychologique

Cocher la bonne réponse. Le but ultime des soins et soutien, selon le document, est de contribuer à :

- A. La réduction des nouvelles infections par la rétention durable dans les soins et la suppression virale
- B. La guérison définitive et complète du VIH
- C. La suppression de tout traitement antirétroviral
- D. L'isolement social du patient pour sa protection

Chapitre 8 — OEV : Soutien à l'éducation et à la mise en apprentissage

I. QCD — Questions à choix direct

Cocher A pour vrai et B pour faux.

La loi ivoirienne rend la scolarisation obligatoire pour tous les enfants de six à seize ans.

Le droit à l'éducation, selon la loi ivoirienne, n'est garanti qu'aux enfants dont les parents sont en bonne santé.

La stigmatisation et la discrimination peuvent conduire un OEV à abandonner l'école.

Les contraintes familiales, comme le statut de chef de famille, n'ont aucun impact sur la scolarisation des OEV.

Les infections opportunistes peuvent entraîner l'exclusion scolaire d'un OEV en raison d'absences répétées.

Les filles OEV du fait du VIH sont à l'abri de tout risque de grossesse non désirée ou de prostitution de survie.

Le manque d'accès à une cantine scolaire peut contribuer à l'abandon scolaire d'un OEV.

Le non-paiement des frais de scolarité peut entraîner l'exclusion d'un OEV des établissements privés.

La plateforme de collaboration OEV comprend quatre missions essentielles.

La plateforme de collaboration OEV est composée uniquement de représentants du secteur de la santé.

Au niveau local, les plateformes OEV sont coordonnées par les Centres Sociaux.

Au niveau national, la coordination des plateformes OEV relève du Ministère en charge de la Famille à travers le PN-OEV.

Les Instituts de Formation et d'Éducation Féminine (IFEFF) font partie des structures d'accueil pour l'apprentissage des OEV.

La sensibilisation des enseignants et éducateurs n'est pas nécessaire pour prévenir la discrimination des OEV.

La mobilisation communautaire peut inclure la création d'AGR pour financer la scolarité des OEV.

II. QCM — Questions à choix multiples

Veuillez cocher la ou les réponse(s) juste(s).

Cocher la bonne réponse. Selon la loi ivoirienne, la scolarisation est obligatoire pour tous les enfants âgés de :

- A. 3 à 6 ans
- B. 6 à 16 ans
- C. 10 à 18 ans
- D. 6 à 12 ans uniquement pour les filles

Cocher la bonne réponse. Parmi les problèmes suivants, lequel n'est PAS cité comme obstacle à la scolarisation des OEV ?

- A. La stigmatisation et la discrimination
- B. Les infections opportunistes
- C. L'excès de moyens financiers familiaux
- D. Les difficultés alimentaires et sanitaires

Cocher la bonne réponse. Les filles devenues OEV du fait du décès de leurs parents sont particulièrement exposées à :

- A. Une meilleure réussite scolaire
- B. Des grossesses non désirées et parfois à la prostitution de survie
- C. Une prise en charge financière automatique par l'État
- D. Aucun risque particulier comparé aux garçons

Cocher la bonne réponse. La plateforme de collaboration OEV a pour mission notamment de :

- A. Remplacer les ministères techniques
- B. Servir de cadre de collaboration entre les différents acteurs locaux
- C. Se substituer aux parents des OEV
- D. Gérer exclusivement les aspects médicaux du VIH

Cocher la bonne réponse. Au niveau local, les plateformes de collaboration OEV sont coordonnées par :

A. Les Centres Sociaux

B. Les hôpitaux

C. Les tribunaux

D. Les entreprises privées

Cocher la bonne réponse. Au niveau national, la coordination des plateformes de collaboration OEV relève :

A. Du Ministère de la Santé exclusivement

B. Du Ministère en charge de la Famille, à travers le PN-OEV

C. De l'ONUSIDA exclusivement

D. Des collectivités locales uniquement

Cocher la bonne réponse. Parmi les structures suivantes, laquelle accueille les OEV pour leur apprentissage en vue d'une insertion socioprofessionnelle ?

A. Les Instituts de Formation et d'Éducation Féminine (IFEFF)

B. Les tribunaux pour enfants

C. Les centres de transfusion sanguine

D. Les commissariats de police

Cocher la bonne réponse. La sensibilisation des milieux de formation (enseignants, éducateurs, conseillers) vise principalement à :

A. Augmenter les frais de scolarité

B. Éviter la discrimination et la stigmatisation des OEV

C. Réduire le nombre d'inscriptions des OEV

D. Remplacer les visites à domicile

Cocher la bonne réponse. La mobilisation de la communauté pour le soutien à l'éducation des OEV peut notamment passer par :

A. La création d'AGR (activités génératrices de revenus) pour collecter des fonds

B. L'exclusion des chefs de village de toute réflexion

C. La suppression des visites à domicile

D. L'arrêt de toute collaboration avec les leaders religieux

Cocher la bonne réponse. Le soutien à l'éducation et à la mise en apprentissage des OEV s'inscrit dans le domaine :

A. Exclusivement médical

B. De l'éducation

C. Exclusivement judiciaire

D. Exclusivement économique

Chapitre 9 — OEV : Soutien pour le renforcement économique

I. QCD — Questions à choix direct

Cocher A pour vrai et B pour faux.

Le renforcement économique consiste à apporter un appui technique, matériel et financier aux familles d'OEV pour leur autonomie financière.

L'index de l'évaluation du ménage (IEM) est un outil permettant d'évaluer les besoins réels d'une famille.

Les AVEC (Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit) n'ont aucun lien avec le soutien économique des familles d'OEV.

Le placement en institution (orphelinat, village SOS) est envisagé en dernier recours, lorsqu'aucun

substitut parental n'est trouvé.

Face aux problèmes alimentaires, il est recommandé de référer les familles vers les centres sociaux et centres de démonstration nutritionnelle.

La planification de la succession n'est pas un enjeu pertinent pour les familles d'OEV en lien avec le VIH.

Sensibiliser les parents au mariage civil et à la rédaction d'un testament fait partie des actions recommandées pour la planification de la succession.

La visite à domicile (VAD) débute directement par la vérification des données sans étape de préparation préalable.

Lors d'une visite à domicile, l'intervenant social doit rassurer le système bénéficiaire du caractère confidentiel de l'entretien.

La vérification des données lors d'une VAD porte notamment sur l'état civil, la situation matrimoniale et le revenu de la famille.

L'enquête sociale permet à l'intervenant social de recueillir des informations pour donner une réponse appropriée au problème à résoudre.

Le rapport d'enquête sociale ne comporte ni diagnostic social ni conclusion.

Le renforcement économique s'inscrit dans le domaine dit « Domaine Stabilité ».

Les activités génératrices de revenus (AGR) ne font pas partie des stratégies de renforcement économique proposées aux familles d'OEV.

Le retrait de l'intervenant social à la fin d'une VAD peut inclure la programmation d'un autre rendez-vous si nécessaire.

II. QCM — Questions à choix multiples

Veuillez cocher la ou les réponse(s) juste(s).

Cocher la bonne réponse. Le renforcement économique des familles d'OEV a pour but :

- A. De les rendre dépendantes de l'aide extérieure durablement
- B. De les rendre autonomes financièrement pour subvenir aux besoins de leurs enfants
- C. De remplacer intégralement leurs revenus par des dons
- D. De limiter leur accès aux structures de soins

Cocher la bonne réponse. L'outil permettant d'évaluer les besoins réels d'un ménage est appelé :

- A. Le PN-OEV
- B. L'index de l'évaluation du ménage (IEM)
- C. Le carnet de vaccination
- D. La fiche d'éligibilité PrEP

Cocher la bonne réponse. Face à des problèmes de logement d'une famille d'OEV, le placement en institution (orphelinat, village SOS) est envisagé :

- A. Comme première option systématique
- B. En dernier recours, si aucun substitut parental n'est trouvé
- C. Uniquement pour les enfants de plus de 15 ans
- D. Jamais, quelle que soit la situation

Cocher la bonne réponse. Face aux problèmes de nutrition, il est recommandé notamment de :

- A. Ignorer la situation si elle n'est pas urgente
- B. Identifier des activités primaires de subsistance et référer vers les centres de démonstration nutritionnelle
- C. Retirer l'enfant de sa famille systématiquement
- D. Attendre l'intervention exclusive de l'État

Cocher la bonne réponse. Concernant la planification de la succession pour les familles d'OEV, il est recommandé de :

- A. Décourager le mariage civil des parents
- B. Encourager le mariage civil et la rédaction d'un testament
- C. Ne jamais aborder ce sujet avec les familles
- D. Laisser la communauté gérer seule les biens sans sensibilisation

Cocher la bonne réponse. La première étape d'une visite à domicile (VAD) est :

- A. La vérification des données
- B. Le retrait de l'intervenant social
- C. La préparation (disponibilité, connaissance du dossier, prise de rendez-vous)
- D. La rédaction du rapport final

Cocher la bonne réponse. Lors de la conduite d'une visite à domicile, l'intervenant social doit notamment :

- A. S'asseoir immédiatement sans attendre d'y être invité
- B. Rassurer la famille sur la confidentialité de l'entretien
- C. Éviter tout contact visuel avec la famille
- D. Limiter l'entretien à moins d'une minute

Cocher la bonne réponse. Parmi les éléments suivants, lequel est vérifié lors de l'étape de vérification des données d'une VAD ?

- A. Le revenu de la famille
- B. Le carnet scolaire de l'enfant uniquement
- C. Le groupe sanguin des parents
- D. La couleur du logement

Cocher la bonne réponse. Le rapport d'enquête sociale comprend notamment :

- A. L'identification, la composition familiale, la situation économique et le diagnostic social
- B. Uniquement la situation économique
- C. Uniquement le diagnostic médical
- D. Uniquement le nom de l'intervenant social

Cocher la bonne réponse. Selon le document, le renforcement économique s'inscrit dans :

- A. Le Domaine Stabilité
- B. Le Domaine Sanitaire exclusivement
- C. Le Domaine Éducatif exclusivement
- D. Le Domaine Judiciaire exclusivement

Chapitre 10 — OEV : Soutien à la protection

I. QCD — Questions à choix direct

Cocher A pour vrai et B pour faux.

La Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE) a été adoptée le 20 novembre 1989.

Selon la CDE, la responsabilité première de la protection de l'enfant incombe exclusivement à l'État.

La non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie/survie/développement et le respect de l'opinion de l'enfant sont les quatre principes fondamentaux de la CDE.

Le respect de l'opinion de l'enfant place celui-ci au-dessus de l'autorité parentale.

Les OEV en lien avec le VIH et le sida ont des droits différents des autres enfants du fait de leur statut.

Le droit à une identité et à une nationalité fait partie des droits fondamentaux reconnus à tout enfant.

La non-déclaration des naissances n'a aucune conséquence sur l'exercice des droits de l'enfant.

La stigmatisation liée au VIH est une réaction négative, réelle ou perçue, envers une personne ou un groupe.

L'accueil et l'enregistrement d'un OEV par l'intervenant social comprend l'identification de l'enfant et de ses parents ou substituts parentaux.

La référence active intervient lorsque l'intervenant social est en mesure de résoudre lui-même tous les problèmes juridiques de l'OEV.

Le suivi actif consiste à rester en relation avec la structure de référence pour s'informer de la suite réservée au problème.

La déclaration de naissance doit être effectuée à la mairie ou à la sous-préfecture dans un délai de trois mois après la naissance.

Passé le délai légal de déclaration de naissance, la procédure de jugement supplétif permet d'établir l'acte de naissance de l'enfant.

Le testament est un acte juridique par lequel une personne exprime ses dernières volontés concernant la répartition de ses biens après son décès.

Selon le CDC, un ménage est considéré en sécurité uniquement s'il reçoit un soutien économique, indépendamment de tout autre type d'intervention.

II. QCM — Questions à choix multiples

Veuillez cocher la ou les réponse(s) juste(s).

Cocher la bonne réponse. La Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE) a été adoptée en :

- A. 1979
- B. 1989
- C. 1995
- D. 2000

Cocher la bonne réponse. Parmi les principes suivants, lequel ne fait PAS partie des quatre principes fondamentaux de la CDE ?

- A. La non-discrimination
- B. L'intérêt supérieur de l'enfant
- C. Le droit à la propriété privée
- D. Le respect de l'opinion de l'enfant

Cocher la bonne réponse. Selon la CDE, la responsabilité première de la protection de l'enfant incombe :

- A. À la famille
- B. Uniquement à l'État
- C. Uniquement à l'école
- D. Uniquement aux organisations internationales

Cocher la bonne réponse. Concernant les droits des OEV en lien avec le VIH et le sida, le document précise qu'ils :

- A. Ont des droits réduits par rapport aux autres enfants
- B. Ont les mêmes droits que tous les autres enfants, avec un besoin de soutien spécial
- C. N'ont droit qu'à une prise en charge médicale
- D. Perdent leurs droits civils dès le diagnostic

Cocher la bonne réponse. Parmi les problèmes de protection rencontrés par les OEV figure :

- A. La non-déclaration des naissances à l'état civil

- B. Un excès de reconnaissance administrative
- C. Une surprotection juridique systématique
- D. Aucun problème particulier par rapport aux autres enfants

Cocher la bonne réponse. Lors de l'accueil et de l'enregistrement d'un OEV par l'intervenant social, il faut notamment :

- A. Procéder à l'identification de l'enfant et de ses parents ou substituts parentaux
- B. Refuser d'écouter l'enfant tant qu'un juge n'est pas présent
- C. Éviter de déterminer la nature du problème
- D. Renvoyer systématiquement vers la police sans évaluation

Cocher la bonne réponse. La référence active de l'intervenant social intervient :

- A. Systématiquement, même quand il peut résoudre le problème lui-même
- B. Lorsqu'il se trouve dans l'incapacité d'agir personnellement
- C. Uniquement pour les problèmes médicaux
- D. Jamais, car l'intervenant social doit tout gérer seul

Cocher la bonne réponse. Le délai légal pour déclarer une naissance à la mairie ou à la sous-préfecture est de :

- A. 15 jours
- B. 1 mois
- C. 3 mois (90 jours)
- D. 1 an

Cocher la bonne réponse. Le testament est défini comme :

- A. Un acte juridique unilatéral exprimant les dernières volontés d'une personne sur ses biens
- B. Un contrat entre deux familles
- C. Un document médical uniquement
- D. Une déclaration de naissance tardive

Cocher la bonne réponse. Selon le CDC, un ménage est considéré en sécurité lorsqu'il reçoit des interventions en :

- A. Protection, abri et soins, santé et soutien psychosocial
- B. Uniquement en soutien financier
- C. Uniquement en éducation
- D. Uniquement en soins médicaux

Chapitre 11 — OEV : Soutien psychosocial

I. QCD — Questions à choix direct

Cocher A pour vrai et B pour faux.

Le soutien psychosocial repose sur l'écoute, la parole et l'observation pour aider une personne en difficulté.

Le soutien social se limite exclusivement à l'aspect financier, sans lien avec l'alimentation ou la santé.

Selon Erikson, chaque stade du développement psychosocial de l'enfant est marqué par une crise à résoudre.

Le développement de l'enfant, selon le document, s'étend de la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans.

Un groupe de soutien réunit des personnes ayant des problèmes communs, animées par un facilitateur.

Le Burn Out ou SEPS est un état de perturbation émotionnelle affectant l'efficacité professionnelle

du soignant.

Le jeune âge du soignant et le volontariat sont des facteurs protecteurs contre le Burn Out.

Le Burn Out ne présente que des symptômes physiques, sans dimension psychique ni comportementale.

L'irritabilité et les troubles de l'attention peuvent faire partie des symptômes psychiques du Burn Out.

La consommation excessive d'alcool ou de tabac peut constituer une réaction défensive face au Burn Out.

La prévention du Burn Out ne peut se faire qu'à titre individuel, sans dimension collective ou institutionnelle.

Les espaces de parole font partie des outils de prévention collective du Burn Out.

La référence intervient lorsque l'intervenant social ou la structure n'est pas en mesure d'offrir le service requis.

La contre-référence permet d'informer la structure ayant référé l'OEV du service rendu au bénéficiaire.

Selon l'OMS, le soutien social des PVVIH comprend notamment la fourniture d'aliments et le soutien affectif.

II. QCM — Questions à choix multiples

Veuillez cocher la ou les réponse(s) juste(s).

Cocher la bonne réponse. Le soutien psychosocial se définit comme une relation d'aide basée sur :

- A. L'écoute, la parole et l'observation
- B. Uniquement la prescription médicamenteuse
- C. Uniquement l'assistance financière
- D. Uniquement des tests biologiques

Cocher la bonne réponse. Selon Erikson, le développement psychosocial de l'enfant se caractérise par :

- A. Une absence totale de crise à chaque étape
- B. Une crise à résoudre à chaque stade, par un équilibre entre forces opposées
- C. Un développement figé dès la naissance
- D. Un processus indépendant du contexte familial

Cocher la bonne réponse. Un groupe de soutien a notamment pour objectif de :

- A. Isoler chaque membre de la communauté
- B. Aider les membres à se soutenir mutuellement et à résoudre des problèmes communs
- C. Remplacer le traitement médical
- D. Éviter tout échange entre les participants

Cocher la bonne réponse. Le Burn Out (SEPS) est décrit par l'OMS comme se caractérisant par :

- A. Un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets
- B. Une amélioration de l'efficacité professionnelle
- C. Une absence totale de stress au travail
- D. Un phénomène qui ne touche que les patients, jamais les soignants

Cocher la bonne réponse. Parmi les facteurs favorisant le Burn Out liés au prestataire figurent :

- A. Une grande expérience professionnelle
- B. Le jeune âge du soignant et un manque d'endurance psychique
- C. Une formation approfondie et une bonne qualification

D. L'absence de toute pathologie personnelle

Cocher la bonne réponse. Parmi les symptômes suivants du Burn Out, lequel appartient au domaine somatique ?

- A. La baisse de l'estime de soi
- B. La fatigue, les céphalées et les troubles du sommeil
- C. La consommation de drogues
- D. Le désir de mutation

Cocher la bonne réponse. Parmi les réactions défensives possibles face au Burn Out figurent :

- A. L'abus d'alcool, de tabac ou de nourriture
- B. Une amélioration spontanée sans aucune action
- C. Une augmentation systématique de la performance
- D. Une indifférence totale sans aucun symptôme

Cocher la bonne réponse. La prévention collective ou institutionnelle du Burn Out repose notamment sur :

- A. L'isolement complet du soignant
- B. La création d'espaces de parole et l'organisation de formations collectives
- C. La suppression de toute formation
- D. Le renvoi systématique du personnel affecté

Cocher la bonne réponse. La référence, dans le cadre du soutien psychosocial, intervient lorsque :

- A. L'intervenant social souhaite se décharger sans raison valable
- B. L'intervenant social ou la structure n'est pas en mesure d'offrir le service requis
- C. Le bénéficiaire refuse tout accompagnement
- D. Il n'existe aucune autre structure disponible

Cocher la bonne réponse. La contre-référence a pour but :

- A. D'annuler la référence initiale
- B. D'informer la structure ayant référé l'OEV du service rendu
- C. De facturer les frais au bénéficiaire
- D. De transférer définitivement le dossier sans retour d'information

Chapitre 12 — OEV : Soutien pour l'abri et les soins

I. QCD — Questions à choix direct

Cocher A pour vrai et B pour faux.

Le soutien pour l'abri et les soins vise à assurer un habitat sain et un environnement familial propice à l'épanouissement de l'enfant.

La disponibilité de moustiquaires imprégnées ne fait pas partie des éléments relatifs à l'abri.

Le placement en institution est recommandé comme première solution avant toute autre option d'hébergement.

La formation des parents ou substituts parentaux à l'éducation parentale fait partie du contenu du soutien aux soins.

L'éducation parentale comprend la compréhension du rôle de parent et l'apprentissage des compétences parentales.

La famille nucléaire est généralement la première responsable de l'enfant.

Lorsque la famille nucléaire est disloquée, la famille élargie peut prendre le relais pour l'enfant.

Le Centre Social constitue la structure d'aide la plus proche de la population au niveau de la

protection de l'enfant.

La Politique Nationale recommande que le placement en orphelinat soit une solution permanente et définitive.

Les collectivités locales (conseils régionaux, mairies) disposent généralement d'un fonds social.

Les organisations non gouvernementales ne peuvent en aucun cas contribuer au soutien pour l'abri et les soins des OEV.

Les visites à domicile (VAD) permettent de vérifier les mesures d'hygiène et d'assainissement du logement.

Le suivi vaccinal des enfants ne fait pas partie des stratégies d'intervention relatives aux soins.

L'intervenant social doit évaluer le système de parrainage mis en place pour l'assistance à l'hébergement.

Le développement des stratégies d'intervention pour l'abri et les soins ne nécessite l'implication d'aucun acteur communautaire.

II. QCM — Questions à choix multiples

Veuillez cocher la ou les réponse(s) juste(s).

Cocher la bonne réponse. Le soutien pour l'abri et les soins consiste à assurer, entre autres :

- A. Un habitat sain protégeant contre les dangers
- B. Une prise en charge médicale exclusive
- C. Un accès prioritaire à l'université
- D. Une exemption totale de scolarité

Cocher la bonne réponse. Parmi les éléments suivants relatifs à l'abri, lequel est mentionné dans le document ?

- A. La présence de moustiquaires imprégnées
- B. La présence d'une piscine
- C. Un accès à internet haut débit
- D. Un jardin de plus de 500 m²

Cocher la bonne réponse. Le placement temporaire en institution (orphelinat, pouponnière) est envisagé :

- A. Comme solution de premier choix
- B. Comme dernier recours, à titre temporaire
- C. Uniquement pour les enfants de plus de 15 ans
- D. De façon permanente et définitive

Cocher la bonne réponse. La formation en éducation parentale proposée aux parents/substituts parentaux comprend notamment :

- A. La compréhension du rôle de parent et l'apprentissage des compétences parentales
- B. Exclusivement des cours de cuisine
- C. Exclusivement des notions de droit international
- D. Un apprentissage de langues étrangères

Cocher la bonne réponse. En cas de dislocation de la famille nucléaire, le relais est généralement pris par :

- A. La famille élargie
- B. L'État exclusivement
- C. Une entreprise privée
- D. Aucune structure, l'enfant restant seul

Cocher la bonne réponse. La structure d'aide la plus proche de la population, au niveau des ministères en charge de la protection de l'enfant, est :

- A. Le Centre Social
- B. Le tribunal de commerce
- C. La chambre de commerce
- D. La direction des impôts

Cocher la bonne réponse. Selon la Politique Nationale, le placement d'un enfant en orphelinat ou en pouponnière doit être :

- A. Une décision définitive et irréversible
- B. Une décision temporaire, en continuant la recherche d'une solution familiale
- C. Interdit dans tous les cas
- D. Décidé uniquement par l'enfant lui-même

Cocher la bonne réponse. Parmi les structures suivantes, laquelle dispose généralement d'un fonds social pouvant soutenir les OEV ?

- A. Les collectivités locales (conseils régionaux, mairies)
- B. Les banques commerciales uniquement
- C. Les compagnies d'assurance uniquement
- D. Les casinos

Cocher la bonne réponse. Les visites à domicile (VAD), dans le cadre du soutien à l'abri et aux soins, permettent notamment de :

- A. Vérifier les mesures d'hygiène et d'assainissement du logement
- B. Remplacer entièrement le rôle des parents
- C. Éviter tout contact avec la famille
- D. Se substituer au médecin traitant

Cocher la bonne réponse. Le développement des stratégies d'intervention pour l'abri et les soins nécessite :

- A. L'appui et l'implication de toute la communauté
- B. L'action isolée de l'intervenant social uniquement
- C. L'intervention exclusive de l'État central
- D. Aucune coordination particulière

Chapitre 13 — OEV : Interventions de prévention pour enfants, adolescents et jeunes adultes vulnérables au VIH

I. QCD — Questions à choix direct

Cocher A pour vrai et B pour faux.

Selon l'OMS, la prévention vise uniquement à empêcher l'apparition de la maladie, sans jamais agir sur son évolution une fois établie.

Il existe trois modes de prévention : primaire, secondaire et tertiaire.

La prévention primaire se fait avant l'apparition de la maladie.

La prévention secondaire vise à réduire la prévalence d'une maladie dans une population.

La prévention tertiaire intervient avant l'apparition de la maladie, comme la prévention primaire.

La sensibilisation de masse permet un échange direct et personnalisé avec un petit groupe de participants.

La sensibilisation de proximité est aussi appelée focus group.

La sensibilisation de masse présente un risque élevé de déformation de l'information.

Le plaidoyer consiste en un exposé argumenté visant à convaincre des décideurs pour obtenir un changement.

La communication, dans le cadre du changement de comportement, ne concerne que le savoir théorique, sans dimension de savoir-être ou savoir-faire.

L'adolescence est décrite comme une période clé pour l'ancrage des comportements de santé.

Les supports audiovisuels (films) ne peuvent en aucun cas être utilisés dans les interventions de prévention auprès des jeunes.

La distribution de préservatifs en fin d'intervention est mentionnée comme appréciée des jeunes.

Le manuel de référence national en soins et soutien comprend aujourd'hui dix modules.

Ces dix modules sont regroupés en cinq domaines essentiels : Santé, Éducation, Stabilité, Sécurité et Prévention.

II. QCM — Questions à choix multiples

Veuillez cocher la ou les réponse(s) juste(s).

Cocher la bonne réponse. Selon l'OMS, la prévention est définie comme :

- A. L'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, accidents et handicaps
- B. Le traitement curatif exclusif d'une maladie déjà installée
- C. Une action limitée au seul dépistage
- D. Une démarche réservée aux professionnels de santé uniquement

Cocher la bonne réponse. La prévention qui se déroule avant l'apparition de la maladie, visant à réduire son incidence, est appelée :

- A. Prévention primaire
- B. Prévention secondaire
- C. Prévention tertiaire
- D. Prévention curative

Cocher la bonne réponse. La prévention qui vise à réduire la prévalence d'une maladie au tout début de son apparition, notamment via le dépistage, est appelée :

- A. Prévention tertiaire
- B. Prévention secondaire
- C. Prévention primaire
- D. Prévention palliative

Cocher la bonne réponse. La prévention tertiaire intervient :

- A. Avant l'apparition de la maladie
- B. Au tout début de la maladie
- C. Au cours de la maladie déjà installée, pour limiter les séquelles
- D. Uniquement chez le nouveau-né

Cocher la bonne réponse. La sensibilisation de masse se caractérise notamment par :

- A. Un échange restreint avec un petit groupe
- B. L'utilisation de moyens de communication de masse (télé, radio, réseaux sociaux)
- C. L'absence totale de besoin en ressources financières
- D. Une évaluation d'impact toujours facile à réaliser

Cocher la bonne réponse. La sensibilisation de proximité est également appelée :

- A. Sensibilisation de masse

- B. Focus group
- C. Communication institutionnelle
- D. Plaidoyer national

Cocher la bonne réponse. Le plaidoyer se définit comme :

- A. Un exposé argumenté visant à convaincre ou influencer des décideurs
- B. Une simple distribution de brochures
- C. Un examen médical de routine
- D. Une sanction judiciaire

Cocher la bonne réponse. Parmi les supports d'intervention cités pour la prévention auprès des jeunes figurent :

- A. Le théâtre-débat, les films, les affiches et les brochures
- B. Uniquement les manuels scolaires
- C. Uniquement les réseaux sociaux
- D. Uniquement les campagnes radiophoniques

Cocher la bonne réponse. L'adolescence est considérée comme une période clé de prévention car :

- A. Elle ne présente aucun risque particulier
- B. C'est une période d'ancrage des comportements de santé et d'entrée dans la sexualité
- C. Les adolescents ne sont jamais concernés par le VIH
- D. Elle survient après l'âge adulte

Cocher la bonne réponse. Le manuel de référence national en soins et soutien aux OEV comprend dix modules regroupés en cinq domaines essentiels, à savoir :

- A. Santé, Éducation, Stabilité, Sécurité et Prévention
- B. Politique, Économie, Culture, Sport et Loisir
- C. Agriculture, Industrie, Commerce, Transport et Finance
- D. Nord, Sud, Est, Ouest et Centre